

Kommentarauflösung ISiK Stufe 6

Lfd. Nr	1	Modul	Basis
Kommentar	Problem: Das Feld „recordedDate“ ist verpflichtend, obwohl es für unsere Auswertungszwecke nicht zwingend benötigt wird und zusätzliche Datenübermittlung bedeutet. Bitte: Prüfung, ob dieses Feld optional gestaltet werden kann.		
Auflösung	Im Kontext von ISiK, also zum Datenaustausch von Systemen im Krankenhaus für Versorgungszwecke ist es wie in der Begründung (Musst-Support Comments) beschrieben, medizinisch relevant, dieses Datum zu haben. Wir sehen daher keinen Anpassungsbedarf.		

Lfd. Nr	2	Modul	Basismodul
Kommentar	Problem: Das Feld „performed“ ist für unseren Anwendungsfall nicht in allen Fällen erforderlich und steht dem Ziel einer datensparsamen Übermittlung entgegen. Bitte: Prüfung, ob dieses Feld optional ausgestaltet werden kann.		
Auflösung	Im Kontext von ISiK, also zum Datenaustausch von Systemen im Krankenhaus für die Versorgung ist das Feld „performed“ medizinisch relevant, wie im Reiter "Must-Support Comments" vermerkt. Wir sehen daher keinen Änderungsbedarf.		

Lfd. Nr	3	Modul	Basismodul
Kommentar	Problem: Wir möchten Diagnosen für mehrere organisatorische Ebenen im Krankenhaus abbilden, insbesondere für Krankenhaus, Abteilung und Station. Dabei sollen sowohl Profile für Patient:innen während eines laufenden Aufenthalts mit einer Hauptdiagnose auf Krankenhausebene (hospital-main-diagnosis) als auch Profile für bereits entlassene und abgerechnete Patient:innen mit principal-DRG unterstützt werden. Das aktuell verwendete ValueSet DiagnoseTyp / DiagnosesubTyp bildet diese Anforderungen nicht ausreichend ab. Im ISiK-Profil KontaktGesundheitsEinrichtung steht derzeit im Diagnosis-Subtyp nur der Code department-main-diagnosis zur Verfügung, eine explizite Abbildung einer Hauptdiagnose auf Krankenhausebene ist damit nicht möglich. Relevante Differenzierung: Für unsere Auswertungen benötigen wir insbesondere die Unterscheidung zwischen einer Hauptdiagnose auf Krankenhausebene (hospital-main-diagnosis) und principal-DRG, da diese unterschiedliche fachliche Situationen beschreiben. Diese Differenzierung ist vor allem relevant, wenn zwischen laufenden Aufenthalten und bereits entlassenen sowie abgerechneten Fällen unterschieden werden soll. Zusätzlich benötigen wir die Unterscheidung zwischen einer Hauptdiagnose auf Krankenhausebene (hospital-main-diagnosis) und einer Hauptdiagnose auf Abteilungsebene (department-main-diagnosis). Diese ist notwendig, da die Diagnoseperspektive je nach organisatorischer Ebene unterschiedlich sein kann. Bitte um Prüfung: Wir bitten um Prüfung, ob die Codesysteme aus dem Deutschen Basisprofil, insbesondere KontaktDiagnoseProzedur, sowie aus HL7, insbesondere DiagnosisRole, verwendet werden können, um diese Differenzierungen		
Auflösung	Die Abbildung einer (oder sogar mehrerer) Krankenhaus Hauptdiagnosen ist im Account möglich. Da eine Krankenhaushauptdiagnose aus dem Abrechnungskontext kommt, ist diese dort korrekt aufgehoben und wird da für den kompletten Fall		

	gesetzt: https://gemspec.gematik.de/ig/fhir/isik/basis/6.0.0-rc/StructureDefinition-ISiKAbrechnungsfall.html Die Erfassung der principal-DRG, als auch der hospital-main-diagnosis sind damit möglich. Das von Ihnen genannte Codesystem wird hier in der extension bereits verwendet. Die Abbildung von Hauptdiagnosen auf Abteilungsebene ist dagegen im Encounter möglich: https://gemspec.gematik.de/ig/fhir/isik/basis/6.0.0-rc/StructureDefinition-ISiKKontaktGesundheitseinrichtung.html Wir sehen daher keinen Änderungsbedarf.
--	---

Lfd. Nr	4	Modul	Basismodul
Kommentar	Problem: In mehreren unserer Anwendungsfälle ist ein direkter Patientenbezug aus Datenschutzgründen nicht vorgesehen bzw. nicht zulässig. <i>Das aktuell verpflichtende Element "name" erschwert bzw. verhindert die Nutzung der ISiK-Profilen in diesen Kontexten.</i> Bitte: Prüfung, ob das Feld optional gestaltet werden kann oder alternative Ansätze ohne direkten Personenbezug ermöglicht werden.		
Auflösung	ISiK bildet vom Charakter die Versorgung innerhalb eines einzelnen Krankenhauses, mit Bezug auf einen Patienten ab. In Ihrem Kommentar bzgl. des "recordedDate" an einer Diagnose haben Sie das Thema "Auswertungszweck" aufgeworfen. Das hört sich für uns eher nach einem Forschungsthema an. Hierfür wären unserer Ansicht nach eher die MII Forschungsdatenschnittstellen geeignet.		

Lfd. Nr	5	Modul	Basismodul
Kommentar	Aus der Implementierung und Evaluation des MII-Fallmodells möchten wir Rückmeldung geben zu ISiK. In den MII-Standorten zeigt sich eine heterogene Datenlage über die drei Encounter-Ebenen: Einrichtungskontakte sind praktisch überall verfügbar, Abteilungskontakte deutlich seltener, während Informationen zu Versorgungsstellenkontakten wieder häufiger vorliegen. Die MII hat die ISiK-Empfehlung übernommen, bei Diagnosen über Condition.encounter auf den Abteilungskontakt zu referenzieren und Rollen wie Haupt-/Nebendiagnose über Encounter.diagnosis abzubilden. Von Standorten wurde jedoch zurückgemeldet, dass Diagnosen häufig auf Ebene der Versorgungsstelle entstehen und sich nicht immer auf einen Abteilungskontakt abbilden lassen. In der Praxis liegt außerdem oft nur die Information Hauptdiagnose/Nebendiagnose für den gesamten Fall bzw. Einrichtungskontakt vor; diese wird dann über Encounter.diagnosis an den Einrichtungskontakt geschrieben. Regelmäßig entsteht zudem die Frage, warum es in ISiK/MII nicht drei getrennte Profile für Einrichtungskontakt, Abteilungskontakt und Versorgungsstellenkontakt gibt. Bei Verwendung eines gemeinsamen Profils für alle Ebenen ist für Implementierende nicht eindeutig, welche Informationen auf welcher Ebene erwartet werden. Werden alle drei Ebenen implementiert, werden redundante Angaben bemängelt, etwa wenn Fachabteilungsschlüssel auf allen Ebenen mitgeführt werden. Wir schlagen daher vor, die Modellierung der drei Ebenen noch einmal gemeinsam zwischen ISiK und MII zu schärfen: Welche Ebene muss welche Information tragen? Welche Ressourcen müssen auf den Abteilungskontakt referenzieren, und wo		

	sollten Einrichtungskontakt oder Versorgungsstellenkontakt zulässig bzw. empfohlen sein (Bsp. auch Labor oder Medikation: auf welchen Encounter referenzieren)? Für Diagnosen wäre eine abgestufte Empfehlung hilfreich, die die reale Datenverfügbarkeit berücksichtigt und nicht voraussetzt, dass ein belastbarer Abteilungskontakt immer vorhanden ist.
Auflösung	Vielen Dank für den Hinweis. Inhaltlich werden wir uns mit dem Thema so bald wie möglich im Rahmen einer geplanten Zusammenarbeit zwischen gematik und MII widmen. Für die Stufe 6 werden zum jetzigen Zeitpunkt daraus keine Änderungen mehr ableitbar sein.

Lfd. Nr	6	Modul	Basismodul
Kommentar	Mir ist aufgefallen, dass Terminologieressourcen teilweise fehlende Angaben zur Sprache (z.B. https://gemspec.gematik.de/ig/fhir/isik/basis/6.0.0-rc/ValueSet-ISiKBehandlungsergebnisReha.html) aufweisen. Dies führt zu vermeidbaren Unklarheiten bei Nutzung, Weiterverarbeitung und internationaler Einordnung. Die Sprachangabe ist kein optionales Detail, sondern ein zentrales Metadatum für korrektes Rendering, Validierung und semantische Interpretation. Die Sprache muss für alle Terminologieressourcen verbindlich angegeben werden. Dies gilt insbesondere für Ressourcen, die mehrsprachige Inhalte enthalten oder in internationalen Kontexten referenziert werden. Eine saubere Sprachkennzeichnung ist Voraussetzung für ein konsistentes Sprachhandling – insbesondere im Zusammenspiel mit Mehrsprachigkeit, Übersetzungen, Terminologie-Servern und Suchmechanismen. Sie trägt damit wesentlich zur Interoperabilität und technischen Verlässlichkeit der publizierten Inhalte bei. Handlungsempfehlung: Für Stufe 7: Ergänzung der fehlenden Sprachangaben in den Terminologieressourcen.		
Auflösung	Im Rahmen der Stufe 6 haben wir auf Grundlage der Anfrage die Sprachmetadaten für ISiK-eigene CodeSysteme im Folgenden Pull Request umgesetzt: https://github.com/gematik/spec-ISiK-Basismodul/pull/1214 In Stufe 7 werden wir uns dem Thema weiter widmen.		

Lfd. Nr	7	Modul	Basismodul
Kommentar	Der aktuell praktizierte Gleichlauf von Paketversion und Business-Version der enthaltenen Terminologieressourcen ist kritisch zu hinterfragen. Eine automatische Anpassung der Business-Version bei jeder Paketänderung - auch ohne inhaltliche Modifikation der Ressource - führt zu semantischer Unschärfe und untergräbt die Nachvollziehbarkeit fachlicher Änderungen. Die Änderung der Business-Version einer Terminologieressource sollte immer dann erfolgen, wenn sich der Inhalt der Ressource ändert. Alleinige Rebuilds rechtfertigen keine neue Business-Version. Ein erzwungener Gleichlauf kann zu Inkonsistenzen führen. Hier besteht die Gefahr, dass Versionserhöhungen suggerieren, es habe eine inhaltliche Änderung gegeben, obwohl tatsächlich lediglich ein Rebuild erfolgt ist. Handlungsempfehlungen: Für Stufe 7 Sollte kritisch hinterfragt werden, ob ein Gleichlauf - wirklich zielführend ist.		
Auflösung	Wir werden uns diesem Thema im Zuge der Stufe 7 widmen.		

Lfd. Nr	8	Modul	Basismodul
Kommentar	Grundsätzlich sollte eine Unterscheidung zwischen dem Autor und dem Publisher einer Terminologie-Ressource vorgenommen werden. In zukünftigen Versionen von FHIR sieht der Standard das bereits korrekt vor. Für R4 sind wir hier auf Extensions angewiesen. Handlungsempfehlung Vorschlag Stufe 7: Die Author Extension (https://hl7.org/fhir/extensions/StructureDefinition-artifact-author.html) sollte genutzt werden, sofern klar ist, wer der Autor ist.		
Auflösung	Wir teilen die Einschätzung, dass die Publisher-Informationen einer Terminologie wichtig sind. Wir werden diese Information im Zuge der Stufe 7 integrieren.		

Lfd. Nr	9	Modul	Basismodul
Kommentar	In den manchen gültigen ISiK FHIR-Profilen ist das Element Coding.version weder verpflichtend noch als Must-Support ausgezeichnet. Dadurch bleibt bei kodierten Daten unklar, gegen welche Version eines CodeSystems eine Instanz tatsächlich erstellt wurde. Diese fehlende Versionsangabe führt dazu, dass Validierungs- und Verarbeitungsprozesse nicht deterministisch arbeiten können: dieselbe Instanz kann je nach Terminologie-Release oder Zeitpunkt der Prüfung unterschiedliche Validierungsergebnisse liefern. Für empfangende Systeme ist nicht zuverlässig erkennbar, welche Semantik der übermittelte Code zum Zeitpunkt der Erfassung hatte. Besonders kritisch ist dies in Domänen mit regelmäßig aktualisierten Terminologien, in denen sich Inhalte, Gültigkeiten oder Semantiken zwischen Versionen verändern können. Ohne verpflichtende Version ist eine reproduzierbare Validierung ebenso wenig möglich wie eine nachträgliche fachliche oder technische Bewertung bereits erzeugter Instanzen (Audit, Fehleranalyse, Abrechnung, langfristige Archivierung). Im Kontext sektorübergreifender Spezifikationen (ePA, eRezept, ISiK etc.) entsteht zusätzlich eine *Vertragsunklarheit* zwischen Datenproduzenten und -konsumenten: Ein Konsument kann nicht sicher feststellen, ob ein Coding gegen die jeweils vorgeschriebene Terminologie-Version erstellt wurde, was zu Interoperabilitätsproblemen und abweichenden Interpretationen führt. Um diese strukturellen Probleme zu beheben, ist vorgesehen, Coding.version in allen relevanten Profilen auf 1..1 zu setzen und als Must-Support zu kennzeichnen. Dadurch wird sichergestellt, dass jede Instanz eindeutig einer Terminologieversion zugeordnet werden kann und Validierungs-, Verarbeitungs- und Prüfprozesse stabil und nachvollziehbar werden. Ziehe hierzu auch: #german/terminologien > CodeableConcept.version verpflichtend? Empfehlung: für stufe 7 Version 1..1 bei Coding.Version setzen.		
Auflösung	Wir teilen die Einschätzung, dass die Angabe der version eine äußerst relevante Information ist. In anbetracht der ausstehenden Aufnahme in die Best-practice guidelines von HL7 deutschland und des Aufwands einer solchen Änderung, werden wir uns diesem Thema in Stufe 7 widmen.		

Lfd. Nr	10	Modul	Basismodul
Kommentar	Derzeit werden Strukturartefakte (Profile, Extensions, Constraints) und terminologische Artefakte (CodeSysteme, ValueSets) gemeinsam veröffentlicht. Diese gemeinsame Veröffentlichung ist fachlich und organisatorisch nicht sachgerecht. Problemstellung Struktur- und Terminologieartefakte unterliegen unterschiedlichen: • Aktualisierungszyklen • Governance-Strukturen • Qualitätssicherungsverfahren • fachlichen Verantwortlichkeiten • Versionierungslogiken Während Strukturprofile typischerweise an Release-Zyklen der ISiK Stufen gekoppelt sind, unterliegen Terminologien eigenständigen, häufig extern getriebenen Änderungszyklen (z. B. regulatorische Updates, jährliche/mehrjährige Klassifikationsänderungen). Eine gemeinsame Paketierung führt zu: • künstlicher Kopplung unterschiedlicher Release-Zyklen • unnötigen Paketupdates bei rein terminologischen Änderungen • fehlender Austauschbarkeit von Terminologieversionen • erschwerte Dependency-Steuerung • Vermischung von Struktur- und Semantik-Governance Dies widerspricht bewährten Prinzipien (Separation of Concerns). Strukturartefakte definieren syntaktische und modellbezogene Vorgaben. Terminologien definieren semantische Inhalte. Beides sind unterschiedliche Verantwortungsbereiche und müssen auch paketstrukturell getrennt werden. Eine Kopplung impliziert fälschlicherweise, dass: • Terminologieversionen an Profilversionen gebunden sind • oder Profilupdates terminologische Änderungen erzwingen Beides ist fachlich nicht haltbar. Handlungsempfehlung: Vorschlag für Stufe 7: Struktur und Semantik müssen getrennt und unabhängig voneinander versioniert und veröffentlicht werden. Die aktuelle gemeinsame Veröffentlichung ist architektonisch nicht zielführend und muss entsprechend angepasst werden. Deshalb alle Terminologischen Inhalte in Semantik Pakete verschieben.		
Auflösung	Wir teilen die Einschätzung, dass eine Trennung von Struktur und Semantik sinnvoll sein kann. In anbetracht des damit verbundenen Aufwands, werden wir uns diesem Thema in Stufe 7 widmen.		

Lfd. Nr	11	Modul	Basismodul
Kommentar	Im Rahmen eines Projekts der mio42 GmbH in Zusammenarbeit mit dem BfArM wurde eine Standardisierung von Inhalten für die Allergiedokumentation im Kontext des deutschen Gesundheitswesens erarbeitet: https://mio.kbv.de/spaces/ALDOK1X0X0/overview Dabei wurden zwei kuratierte Minimal-ValueSets definiert, die auch bereits das Kommentierungsverfahren des BfArM sowie ein Benehmensverfahren der KBV durchlaufen haben und aktuell im Einvernehmensverfahren mit dem KIG stehen: • „auslösende Substanz“ • „Manifestation“ Ziel ist eine klinisch sinnvolle und interoperable Einschränkung der SNOMED-CT-Konzepte bei gleichzeitiger Beachtung von AMTS-Anforderungen aber auch den Bedürfnissen der klinischen Dokumentation von Patientenallergien laut der eingebundenen Fachgesellschaften. Die ValueSets werden in Kürze auch auf dem ZTS veröffentlicht. Vor diesem Hintergrund ergeben sich folgende Anknüpfungspunkte im ISiK-Profil AllergieUndUnvertraeglichkeit (https://gemspec.gematik.de/ig/fhir/isik/basis/6.0.0-rc/StructureDefinition-ISiKAllergieUnvertraeglichkeit.html): 1. Binding von AllergyIntolerance.code → Prüfung der Einbindung des ValueSets "allergy-intolerance-substance-snomed-ct-1-0-0" und setzen auf <i>preferred</i>. 1. Binding von reaction.manifestation → Prüfung der Einbindung des ValueSets „allergy-intolerance-manifestation-snomed-ct-1-0-0“ Langfristig könnte damit in der nationalen Krankenhauslandschaft ebenso wie im ambulanten Sektor eine harmonisierte Allergie-Dokumentation erfolgen, die semantisch interoperabel und EHDS-konform ist sowie vergleichbare AMTS-Prüfungen erlaubt.		
Auflösung	Wir würden die vorgeschlagenen Valuesets weiterhin gerne in ISiK integrieren. Leider sind zum Zeitpunkt der Benehmensherstellung die Valuesets noch nicht in einem Package veröffentlicht (geplant durch BfArM). Sobald wir Zugang zu den ValueSets erhalten, können wir diese bestenfalls in eine laufende (Technical Correction) oder künftige ISiK-Version integrieren.		

Lfd. Nr	12	Modul	Basismodul
Kommentar	Der eingebettete Link zu Vorversion der ISiK-Version 6 führt zur ePA-Historie. Wo? https://gemspec.gematik.de/ig/fhir/isik/basis/6.0.0-rc/index.html unter "1 Einführung" unmittelbar vor der nächsten Überschrift.		
Auflösung	Der Link wurde korrigiert.		

Lfd. Nr	13	Modul	Basismodul/ Terminplanung
Kommentar	im Punkt der „Client-Performance“ wird erwähnt, „unnötige Wiederholungsabfragen“ zu vermeiden. Das ist grundsätzlich richtig, allerdings wäre es sehr wichtig die Slot-Abfragen während der Terminbuchungs-Journey nicht als unnötig, sondern als notwendig und erwartet definiert werden. Hier scheint es im Markt noch keine Einigung zu geben. Kernproblem: Terminslots werden auf den Servern nach der Abfrage nicht reserviert/geblockt. Zwischen initialer Suche und finaler Buchung vergehen oft mehrere Minuten (Suche, Login bzw. Registrierung, Auswahlprozess). Eine einmalige Slot-Abfrage am Anfang erhöht das Risiko zu Ablehnungen am Ende, weil inzwischen jemand anderen diesen Terminslot bebucht hat. Erfährt der Portalnutzer dies erst am Ende seiner Reise, stört das die User Experience und mindert Vertrauen in die Zuverlässigkeit. Lösung: Mehrfache Slot-Abfragen während des Prozess, um Nutzer passend zu leiten, sind notwendig und sollten als Standard akzeptiert und nicht als „Performance-Belastung“ gesehen werden. Konkreter Prozess: 1. Suche Termin auf Portal → Slot-Abfrage (Verfügbarkeit zeigen) 2. Nutzer wählt Slot aus → Slot-Abfrage (Validierung vor Buchung) 3. Ggf. Nutzer meldet sich an / Zeit vergeht → Slot-Abfrage (noch verfügbar?) 4. Buchung wird versendet →OK/ NOK vom Server 5. Falls Ablehnung: Auto-Abfrage alternativer Slots und sofort anbieten Wunsch an die gematik: Definition im Standard explizit, dass mehrfache Slot-Validierungen während der Terminbuchungs-Journey nicht als „unnötig“ zu klassifizieren sind, sondern als Systemanforderung.		
Auflösung	Einen entsprechenden Hinweis haben wir der Spezifikation mit folgendem Pull Request hinzugefügt: https://github.com/gematik/spec-ISiK-Basismodul/pull/1229		

Lfd. Nr	14	Modul	Basismodul/ Terminplanung
Kommentar	Anbei unsere Kommentierung zum Performance Requirements (PR #1068) Wir halten die Performance-Anforderung mit <60 Sekunden Response Time für zu großzügig angelegt, denn sie führt zu Patientenfrust, sowie potentieller Systeminstabilität. Wir würden eine explizit strengere Anforderung an die FHIR-Server sehr begrüßen, denn wir sehen im Markt, dass der Performance Aspekt aus Mangel an Erfahrung oft vernachlässigt und nicht berücksichtigt wird. Performance-Anforderungen sollten idealerweise nach Operationstyp differenzieren: 1. Slot-Request Empfehlung: <15 Sekunden durchschnittliche Response-Zeit Begründung: • Ohne klare SLA müssen Plattformen konservativ lange Client-Timeouts setzen (heute: 10–30s)		

	• Das führt zu vielen parallel offenen Requests auf ISiK-Seite ◦ Vor allem zu Spitzenzeiten, wenn mehrere Patienten gleichzeitig einen Termin suchen (Montags morgen). • Beobachtungen und Studien zeigen deutlich, dass bei Nutzern ab 10 Sekunden die Konzentration & Compliance wegbricht, der Frust enorm steigt und unerwünschtes Verhalten immer wahrscheinlicher wird. Einen Teil kann man mit entsprechender UI/ Info abfangen, aber nicht alles. ◦ Nutzer refreshen die Webseite, weil sie denken etwas läuft schief ◦ Nutzer probieren es parallel erneut in einem neuen Tab/ auf einem anderen Gerät, weil sie denken da geht es schneller ◦ Nutzer brechen den Vorgang ab, weil sie denken es geht nicht und kontaktieren das KH entweder anderweitig (Adminlast) oder wandern ab (Patientenverlust) ◦ Insgesamt vermindert sich die Patientenzufriedenheit deutlich • Bei Spitzenlast entstehen Cascading Failures 2. Booking Status (confirmed/ pending) Ziel: <2 Sekunden durchschnittliche Response-Zeit Begründung: • Das Doppelbuchungsrisiko steigt überproportional bei längerer Responsezeiten • Nutzer benötigen eine zügige Rückmeldung, ob ihre Buchung / Anfrage geklappt hat oder nicht. Mehr noch als bei der Slotabfrage, steigt mit der Wartezeit die Verunsicherung der Patient:innen, inkl. unerwünschtes Verhalten.
Auflösung	Wir haben Ihre Hinweise in einer neuen Seite zur Performance im Terminplanungsmodul aufgenommen: https://github.com/gematik/spec-ISiK-Basismodul/pull/1218

Lfd. Nr	15	Modul	Dokumentaustausch
Kommentar	Das Profil ISiKDokumentenMetadaten verlangt aktuell einen Patientenbezug (Patient Reference). In der Praxis existieren aber Dokumente ohne Patientenkontext, z. B.: • Hygieneberichte • QM-Dokumente • Betriebsanweisungen • Geräteprotokolle Diese lassen sich damit formal nicht profilkonform abbilden. Ist es denkbar das Modul auf diesen UseCase zu erweitern?		
Auflösung	Nach Diskussion in der Arbeitsgruppe zur Kommentierung besteht aktuell kein Bedarf zum Abruf von Dokumenten ohne Patientenkontext.		

	Aus diesem Grund wird dieser Use-Case für Stufe 6 nicht aufgenommen.
--	--

Lfd. Nr	16	Modul	AMTS
Kommentar	ISiKDiagnose: 1. Beim TypeChoice Slicing von onset und abatement werden einzelne Datentypen doppelt angezeigt, bitte das Slicing prüfen. 2. Die lebensphase Extension wird hier jeweils am Datentyp Age angehängt, während es bei den KBV Profilen an Range hängt. Hier sollte harmonisiert werden. 3. Die BodyStructureReference Extension ist hier unter bodySite statt auf einer Ebene mit bodySite, wie bei HL7 EU IGs.		
Auflösung	1) Das angesprochene Slicing ist korrekt. Die doppelte Anzeige resultiert aus einem bekannten Bug des IG-Publishers (https://github.com/HL7/fhir-ig-publisher/issues/1233) 2) Zur Frage Range vs Age konnten wir während der Kommentierung keine abschließende Entscheidung treffen. Wir würden in der Frage gerne eine Abschließende von EU Seite abwarten - vgl. EU Extension: https://build.fhir.org/ig/hl7-eu/extensions/StructureDefinition-periods-of-life.html 3) Im aktuellen EU Base/Core 2.0.0 Package von Ende April ist die Extension unterhalb von bodySite und nicht auf selber Ebene. D.h. wir können der Aussage, dass die extension in EU-Core für die extension eine andere Ebene als ISiK vorsehe, nicht folgen und sehen keinen unmittelbaren Anpassungsbedarf in ISiK. Wir können in Zukunft gerne gemeinsam auf eine Harmonisierung der EU Profile "HL7 Europe Laboratory Report" und der Condition aus der EU Base hinwirken.		

Lfd. Nr	17	Modul	AMTS
Kommentar	Bei AllergyIntolerance: Vielleicht zu berücksichtigen: abatement Extension. Siehe KBV-Basis-Profile.		
Auflösung	Die entsprechende Extension `abatement` haben wir in folgendem Pull Request hinzugefügt: https://github.com/gematik/poc-isik-general/issues/28		

Lfd. Nr	18	Modul	AMTS
Kommentar	https://gemspec.gematik.de/ig/fhir/isik/amts/6.0.0-rc/StructureDefinition-ISiKProzedur.html (und weitere) Die Extension für BodyStructure Reference sollte auf gleicher Ebene wie bodySite Element passieren und nicht als Extension am bodySite Element selbst. Dann wäre es konsistent mit EHDS Modellierweise, siehe: https://build.fhir.org/ig/hl7-eu/laboratory/StructureDefinition-Specimen-eu-lab.html → Specimen.collection.extension:bodySite		
Auflösung	Wir haben uns hier an die EU Core/Base Vorgehensweise gehalten: https://build.fhir.org/ig/hl7-eu/base/StructureDefinition-procedure-eu-core.html Es scheint somit zunächst ein Harmonisierungsbedarf in den HL7 EU Profilen zu geben - https://build.fhir.org/ig/hl7-eu/laboratory/StructureDefinition-Specimen-eu-lab.html vs https://build.fhir.org/ig/hl7-eu/base/StructureDefinition-procedure-eu-core.html .		

	Eine unmittelbare Anpassung in ISiK erscheint nicht zweckdienlich. Wir können uns hier weiter abstimmen, z. B. im Sinne einer gemeinsamen Einreichung eines Kommentars bei HL7 EU.
--	--

Lfd. Nr	19	Modul	AMTS
Kommentar	MedicationRequest.extension:medicationRequestReplaces Stattdessen sollte vielleicht eher eine r5-backport extension genutzt werden für das Element MedicationRequest.priorPrescription https://hl7.org/fhir/medicationrequest.html		
Auflösung	Die genannte extension wurde in folgendem Pull Request ersetzt: https://github.com/gematik/spec-ISiK-Basismodul/pull/1192		

Lfd. Nr	20	Modul	AMTS
Kommentar	An folgenden Stellen ist die Referenz auf den Datentypen Dosage im AMTS IG kaputt: MedicationRequest.dosageInstruction ISiKMedikationsInformation.dosage		
Auflösung	Der Fehler wurde behoben: https://github.com/gematik/spec-ISiK-Basismodul/pull/1190/changes#diff-ad1652ab0056b31748dc2edb172a3c45ee087f7b6e8e4a1e3aa3d27b3b32df2e Siehe Änderung an der sushi-config.yml im publisher-guides/Medikation Ordner.		

Lfd. Nr	21	Modul	Labor
Kommentar	https://simplifier.net/isik-stufe-6/isiklaboruntersuchungserumnatrium Die category slices und die angefügten Bindings weichen von den EHDS (HL7 Europe Laboratory Report) Festlegungen ab. Beispiel: category slice studyType mit https://build.fhir.org/ig/hl7-eu/laboratory/ValueSet-lab-studyType-eu-lab.html während bei ISiK ein eigenes abweichendes ValueSet und andere Slice-namen definiert werden. Auch sind beim European Lab Report nur effectiveDateTime und effectivePeriod erlaubt, bei ISiK jedoch noch weitere Datentypen. Bitte in den Laboruntersuchung-Profilen in ISiK EHDS Konformität beachten.		
Auflösung	Zu der angeregten Angleichung an den EHDS möchten wir anmerken, dass für die Laborprofile bisher keine Obligations definiert wurden und ein Abgleich aus diesem Grund schwierig ist. Hinsichtlich des Bindings möchten wir darauf hinweisen, dass unser aktuelles Binding nahezu alle Codes umfasst, die im EHDS für die entsprechende Category definiert wurden – mit Ausnahme von Microbiology Studies. Wir sehen hier daher keinen unmittelbaren Handlungsbedarf. Was die Slice-Bezeichnungen betrifft: Wir haben bislang bei keiner der bisherigen Anpassungen in Richtung EHDS die Slice-Bezeichnungen geändert und möchten auch hier konsistent verfahren. Der Punkt zu effectiveDateTime wird von uns anders bewertet. In ISiK haben wir lediglich effectiveDateTime mit Must Support (MS) versehen. Zwar schränken wir den Datentyp darüber hinaus nicht weiter ein, jedoch ist eine nach ISiK-MS erstellte Instanz valide. Eine weitergehende Einschränkung auf bestimmte Typen könnte im Rahmen		

	einer künftigen Harmonisierung geprüft werden – ob dies für ISiK in Frage kommt, wäre dort zu evaluieren.
--	---

Lfd. Nr	22	Modul	Labor
Kommentar	Die MII hat für den Entnahmezeitpunkt eine Probe eine Extension definiert: https://simplifier.net/mii-basismodul-labor-2025/mii_ex_labor_quelle_klinisches_bezugsdatum welche effective weiter kodiert/definiert. Die KBV hat diesen textuelle Guidance: Eine Laboruntersuchung bezieht sich eindeutig auf ein Probenmaterial, zu dem (1.) der Entnahmezeitpunkt bekannt sein sollte/kann und (2.) der Laboreingangszeitpunkt bekannt sein muss. Verbindliche Regel zur Ableitung des klinischen Bezugszeitpunkts: WENN der Entnahmezeitpunkt des Probenmaterials angegeben ist, so gilt der Entnahmezeitpunkt; WENN der Sammelzeitraum, bis angegeben ist, so gilt der bis-Zeitpunkt; SONST gilt der Zeitpunkt des Eingangs der Probe im Labor (Probeneingangszeitpunkt). Ich gehe davon aus, dass die Information zur Befüllung der Extension in den KIS-Systemen nicht verfügbar ist und präferiere daher die Übernahme der Definition der KBV (o.ä).		
Auflösung	Die textuelle Guidance kann zum Nächstmöglichen Zeitpunkt (auch als TC) in ISiK aufgenommen werden.		

Lfd. Nr	23	Modul	Formular
Kommentar	Release Note – Neue Anforderung an den FormularRenderer zur Erzeugung eines menschenlesbaren Narratives Die Anforderung, ein Narrative über QuestionnaireResponse.text oder als Teil des Document-Bundles zu transportieren, wirft eine Mehrsprachigkeitsfrage auf: Narrative unterstützt keine i18n, sodass faktisch immer eine einzelne Sprache (vermutlich Deutsch) erzeugt würde. Wir bitten um Klarstellung: Welche Sprache ist normativ vorgesehen – die deutsche Amtssprache oder die im zugrundeliegenden Questionnaire}}deklarierte Sprache ({{Questionnaire.language bzw. QuestionnaireResponse.language)? Wie soll mit mehrsprachigen Questionnaires (z. B. PREMs in mehreren Sprachen) umgegangen werden? Empfehlung: Die Sprachvorgabe sollte explizit dokumentiert werden, ggf. als normative SHALL/SHOULD-Anforderung an den FormularRenderer. Es gibt einen Absatz zu Multi languag support in Narrative: https://hl7.org/fhir/R4/narrative.html#lang		
Auflösung	Wir haben die folgenden Anpassungen an der Spec aufgrund des Kommentars vogenommen: Zunächst wurde das language-Element sowohl in der FormularDefinition als auch in den FormularDaten als Pflichtfeld (1..1, Must-Support) aufgenommen. Damit muss künftig immer explizit angegeben werden, in welcher Sprache ein Formular bzw. die zugehörigen Daten vorliegen. Im ISiK-Kontext ist dies in der Regel de-DE (Deutsch/Deutschland). Begründet ist die Pflichtangabe damit, dass die Sprache für die korrekte		

	Interpretation und Darstellung der Formularinhalte relevant ist. Ergänzend wurde das language-Element auch in allen mitgelieferten Beispiel-Ressourcen (Questionnaire und QuestionnaireResponse) auf de-DE gesetzt. Darüber hinaus wurde der Implementierungsleitfaden um eine neue Best-Practice-Sektion „Mehrsprachigkeit von Formularen" erweitert. Diese beschreibt zwei mögliche Wege, mehrsprachige Formulare zu modellieren: • Der erste Ansatz nutzt die Translation-Extension für die Übersetzung von Texten sowie Designations in ValueSets für die Übersetzung von Antwortoptionen. Hierbei bleibt eine einzige Formulardefinition als zentrale Quelle bestehen, die Sprachauswahl erfolgt zur Laufzeit durch den Renderer. Vorteilhaft sind die Pflege an einer Stelle und die Flexibilität zur Laufzeit; nachteilig sind die zunehmende Komplexität der Definition und die notwendige Unterstützung der Translation-Extension durch den Renderer. • Der zweite Ansatz sieht je Sprache eine eigene Formulardefinition vor, die sich im language-Element sowie über ein Sprach-Suffix in der URL unterscheidet und über derivedFrom mit den anderen Sprachversionen verknüpft wird. Dieser Weg führt zu übersichtlichen, klar getrennten Definitionen und erlaubt auch sprachspezifische Strukturunterschiede, bringt jedoch Redundanz und einen erhöhten Synchronisationsaufwand zwischen den Sprachversionen mit sich. Beide Varianten werden bewusst gleichwertig und ohne Empfehlung dargestellt – hier wird ausdrücklich um Feedback aus der Praxis gebeten, um die Best Practices zu diesem Thema weiterzuentwickeln.
--	---

Lfd. Nr	24	Modul	Formular
Kommentar	Bezug: Seite „Übergreifende Festlegungen" (nicht in den Release Notes erwähnt) Die Seite befindet sich nicht auf dem aktuellen Stand. Insbesondere die Beschreibung der Extraktion entspricht nicht mehr der aktuellen Spezifikation und muss überarbeitet werden.		
Auflösung	Die Seite wird aktualisiert.		

Lfd. Nr	25	Modul	Formular
Kommentar	Bezug: Seite „AkteureOhneCpS" – Anforderung an FormularDefinitionsErsteller (Quelle) Aus der Spezifikation: „Ein System, welches die Funktionalität zur Erstellung von FormularDefinitionen bereitstellt, darf nur Funktionalitäten anbieten, die im Profil FormularDefinition mit Must-Support gekennzeichnet, oder auf der Seite Extensions nicht als Out-of-scope Extension gelistet sind. (SHALL)" Wir widersprechen dieser Formulierung. Der IG sollte normativ nur Aussagen über das treffen, was im Scope liegt – also über Must-Support-Elemente und explizit zugelassene Extensions. Alles, was außerhalb des IG-Scopes liegt, sollte vom IG nicht reguliert werden, weder erlaubend noch verbietend.		

	Konkrete Probleme der aktuellen Formulierung: 1. Übergriff in Nicht-IG-Funktionalität: Der IG verbietet implizit die Nutzung von Funktionalitäten/Extensions, die er gar nicht behandelt. Das geht über den Zuständigkeitsbereich des Moduls hinaus und schränkt Implementierer in legitimen, IG-fremden Use Cases ein. 2. Konstruktion über eine Negativliste („Out-of-scope Extensions“): Die Out-of-scope-Liste wird durch die SHALL-Konstruktion faktisch zu einer normativen Verbotsliste umfunktioniert, obwohl sie inhaltlich nur abgrenzen, nicht regulieren soll. 3. Hemmnis für Erweiterbarkeit: Hersteller können keine zusätzlichen, anwendungsspezifischen Funktionen anbieten, ohne formell gegen den IG zu verstoßen – auch wenn diese Funktionen die ISiK-Konformität nicht berühren.
Auflösung	Vielen Dank für den Kommentar. Die Seite sollte nie online gehen und wird entfernt.

Lfd. Nr	26	Modul	Formular
Kommentar	Bezug: Release Note – Neues Beispielszenario für den TI-Messenger (TI-M) Das Szenario sollte weiter konkretisiert werden: Die Verlagerung von Vorbelegung und Extraktion in den „TI-M Pro Client“ ist derzeit nur oberflächlich beschrieben. Es fehlen klare Aussagen zu Verantwortlichkeiten, Datenflüssen und Abgrenzung zu den ISiK-Akteuren (FormularLauncher, FormularRenderer). Der Schritt der Dateneingabe sollte als eigenständiger Schritt in den Ablauf aufgenommen werden, damit der End-to-End-Fluss vollständig nachvollziehbar ist (idealerweise in Form eines Sequenzdiagramms).		
Auflösung	Das zugehörige Sequenzdiagramm wurde um den Akteur „Nutzer“ sowie den Schritt der Dateneingabe ergänzt, sodass der End-to-End-Ablauf nun auch die manuelle Eingabe der Daten im Formular explizit abbildet. Die textliche Beschreibung des Szenarios wurde um zwei Abschnitte erweitert. Zum einen wurde eine schrittweise Ablaufbeschreibung in acht Schritten aufgenommen – vom Workflow-Start über die optionale Vorbelegung, den Launch und die Übermittlung von FormularDefinition und FormularDaten, das Rendering, die Dateneingabe durch den Nutzer und die Validierung bis hin zur Rückübermittlung und der optionalen Extraktion und Rückschreibung der Daten in die FormularDatenQuelle. Die als optional gekennzeichneten Schritte (Vorbelegung und Extraktion) sind dabei jeweils nur bei Integration in die Leistungserbringer-Infrastruktur relevant. Zum anderen wurde eine Übersichtstabelle zur Abgrenzung der ISiK-Akteure im TI-M-Kontext ergänzt. Diese ordnet die ISiK-Rollen den jeweiligen TI-M-Komponenten zu: Der FormularDefinitionsVerwalter, FormularDatenVorbeleger und FormularDatenExtraktor entsprechen dem „TI-M Pro Client“, der FormularRenderer dem „TI-M ePA Client“. Der FormularLauncher ist als Standalone-Komponente zu verstehen, die durch das TI-M-interne Protokoll getriggert wird, wobei der Patienten-		

	Kontext übergeben wird und in den FormularDaten genutzt werden kann. Abschließend wurde ein Verweis auf die Vorabveröffentlichung „gemF_TI-M_Strukturierte_Daten“ (Abschnitt 3.3) aufgenommen, in der die Verantwortlichkeiten und Datenflüsse im TI-M-Kontext näher beschrieben sind. Es ist vermerkt, dass dieser Link (Stand 28.05.2026) in einer späteren technischen Korrektur durch die finale Spezifikation ersetzt wird.
--	--

Lfd. Nr	27	Modul	Formular
Kommentar	Auf der Seite „Beispielszenarien“ sollte ein expliziter Verweis (Hyperlink) auf die normative TI-M Spezifikation ergänzt werden. Aktuell ist der Bezug nur narrativ; ein direkter Link erleichtert Implementierern den Übergang vom konzeptionellen Beispiel zur normativen Grundlage.		
Auflösung	Vielen Dank für den Hinweis. Aktuell ist die relevante TI-M Spezifikation noch nicht abschließend veröffentlicht. Wir werden die Verlinkung im Rahmen einer Technical Correction ergänzen sobald dieser vorliegt.		

Lfd. Nr	28	Modul	Formular
Kommentar	Bezug: Release Note – Entfernung des Patient-Patterns am subjectType der FormularDefinition Mit der Öffnung des subjectType für weitere Use Cases (z. B. PREMs) fehlen aktuell Beispiele, die diese Flexibilität illustrieren. Wir bitten um die Aufnahme mindestens eines Beispiels mit subjectType = Organization und/oder CareTeam (z. B. für ein PREM-Szenario), um den intendierten Anwendungsraum sichtbar zu machen und Implementierern eine konkrete Orientierung zu geben.		
Auflösung	Aus der Begründung des Elements geht hervor, dass das Modul sich weiterhin nur auf "Patient" bezieht: Begründung Pflichtfeld: Die in diesem Modul beschriebenen Funktionen und Interaktionen beziehen sich auf den subjectType Patient. Ist hier ein anderer subjectType angegeben, so unterliegt das Formular nicht den Einschränkungen und Anforderungen, die in diesem IG für ISiK-Formulare definiert sind. Um dennoch eine Validität zum Profil herzustellen, wurde das Pattern entfernt. Hinweis: Ist der subjectType Patient gesetzt, ist stets davon auszugehen, dass der Patient, für den dieses Formular ausgefüllt wird, identisch ist, mit dem Patient, der im Launch-Kontext übergeben wird.		